

Convulsão febril · abordagem

Convulsão febril ocorre entre ~6 meses e 5 anos com febre, sem infecção de SNC prévia. A maioria é simples e autolimitada; o foco é ABC, tempo de crise e sinais de meningite.

Crise ativa

Dica - Crise ativa

Se >5 minutos: benzodiazepínico (midazolam/diazepam conforme via disponível). Proteja via aérea, glicemia capilar e não force objetos na boca.

Ramificação: simples !' tranquilizar + antitérmico; complexa/atípica !' investigar e neurologia.



Quando temer SNC / outra causa

- Toxemia, nuchalidade, petéquias, fontanela abaulada
- Lactente muito jovem, convulsão febril atípica ou déficit pós-ictal prolongado
- Vacinação/estado vacinal e epidemiologia (considerar meningite)
- Primeira crise afebril: não rotular como 'febril'

Conduta após a crise

Cenário | Conduta

Simples típica | Observação, orientação, antitérmico; EEG/TC não rotineiros

Complexa | Avaliação mais ampla; imagem/EEG selecionados

Suspeita de meningite | Punção / ATB — não atrasar se grave

Status epilepticus | Protocolo de status + UTI

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Anticonvulsivante de manutenção profilático não é rotina após convulsão febril simples. Educar os pais sobre recorrência e manejo da crise vale mais do que medicar 'para prevenir'.